Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santiago

Av. Batista Bonotto, 157 - Bairro: Centro - CEP: 97711-500 - Fone: (55) 3029-9981 - 55 9 9932 8498 - Email: frsantiago1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007547-12.2024.8.21.0064/RS

AUTOR: VITORIA BOFF DAMIAN
RÉU: MUNICÍPIO DE SANTIAGO / RS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

VITORIA BOFF DAMIAN ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **MUNICÍPIO DE SANTIAGO** e do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** todos qualificados, aduzindo, em síntese, que era possuidora de dermatite atópica – CID 10 I 209, necessitando fazer uso contínuo do medicamento **Dupixent 300mg**. Informou que não tinha condições de arcar com as despesas do medicamento sem prejuízo de toda a sua família, bem assim o tratamento era indispensável à sua saúde. Requereu, a título de tutela provisória de urgência, o fornecimento liminar da medicação e, no mérito, o julgamento de procedência do pedido, com a condenação definitiva do demandado ao fornecimento do fármaco. Solicitou a concessão da gratuidade da justiça. Juntou documentos (eventos 1, 3 e 10).

Requisitada a elaboração de Nota Técnica pelo Natjus (evento 4), sobreveio ao evento 17.

Recebida a inicial e indeferida a antecipação de tutela (evento 22).

O Município de Santiago ofereceu contestação, defendendo, em síntese, não ser parte passiva legítima, tendo em vista a divisão administrativa de responsabilidades dentro do SUS. Sustentou a impossibilidade de fornecimento dos fármacos com base no princípio da legalidade, que orientava a atuação administrativa, inclusive orçamentária, e a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário para a determinação pretendida, em atenção ao princípio da separação dos poderes. Requereu o julgamento de improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o direito de ser ressarcido pela União ou pelo Estado (evento 30).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação discorrendo sobre o julgamento dos temas 1234 e 06 da Repercussão Geral, pelo STF. Disse que o fármaco não é incorporado e que é ônus probatório da parte autora demonstrar com fundamento na Medicina Baseada em Evidências a segurança e eficácia do fármaco postulado, não bastando a simples alegação da necessidade do medicamento. Referiu que a CONITEC decidiu não incorporar o medicamento para o tratamento da patologia que acomete a autora. Postulou a improcedência do pedido (evento 37).

Houve réplica (eventos 35 e 41).

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir (evento 43).

Não foram postuladas provas, vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Santiago, considerando ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, *lato sensu* considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal.

Observo, inclusive, que o STF, quando da fixação de tese no Tema 793/STF, reafirmou, de maneira incontroversa, a presença da solidariedade entre os Entes Públicos na prestação de assistência à saúde pública à população.

No mérito, cuida-se de ação pela qual a autora requer o fornecimento de DUPILUMAB (DUPIXENT) 300mg, por apresentar patologia classificada pelo CID 10 I209 - dermatite atópica, afirmando que o medicamento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

O direito à saúde é reconhecido constitucionalmente como sendo um direito fundamental do cidadão, na medida em que vem elencado no rol de direitos sociais do art. 6º da CF/88.

A matéria também vem disciplinada em seu art. 196, ao dispor que:

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso natural e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Para o cumprimento desse dever constitucional, o Estado brasileiro criou o Sistema Único de Saúde (198, § 1º, da CF[1]) que, por ser universal e gratuito, está amparado na lógica da medicina de evidência, estabelecendo protocolos e diretrizes para a prestação mais efetiva possível com o menor dispêndio de recursos públicos.

Desse modo, se a demanda objetiva uma prestação já reconhecida como integrante do Sistema Único de Saúde, o direito subjetivo do cidadão afigura-se com máxima força; de outro lado, se a demanda tem por objeto prestação não integrante das políticas públicas, está sujeita à ponderação, pois com o direito invocado competem vários outros princípios, e a efetivação somente pode se realizar no limite das possibilidades fáticas e jurídicas do caso.

No caso concreto, o fármaco DUPILUMAB (DUPIXENT) 300mg, não faz parte dos elencos de medicamentos disponibilizados pelo SUS, conforme certidão negativa de evento 1, COMP5**.**

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o **Tema n.º 6** e o **Tema n.º 1234**, definiu diversos critérios para o fornecimento judicial de medicamentos.

A partir dos referidos Temas foram editadas as Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, as quais transcrevo:

Súmula Vinculante n.º 60

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), ***devem observar*** *os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*

Súmula Vinculante n.º 61

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, ***deve observar*** *as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Considerando que a demanda visa o fornecimento de medicamento com registro da ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é necessário observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). São elas:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. ***É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;*** *(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS."*

A autora foi oportunizada a produção de provas, especificamente para comprovar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Ainda, para comprovar a existência de relatório da CONITEC recomendando ou não o uso do medicamento para tratamento da patologia e, em caso de parecer desfavorável, apontar eventual vício de regularidade do procedimento e/ou de legalidade do ato de não incorporação (evento 4, DESPADEC1).

A autora emendou à inicial indicando que o medicamento foi objeto de estudo pela CONITEC (que entendeu pela não incorporação do fármaco no SUS), mas não apontou vício de regularidade do procedimento ou de legalidade do ato de não incorporação, posto que mencionou apenas *"i)Vício de regularidade ou ilegalidade: não se aplica, conforme item anterior*" (evento 10, EMENDAINIC1).

Conforme mencionado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela, a parte autora não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Observo pelo documento acostado no evento 10, COMP5, que a CONITEC, por ausência de custo-efetividade e diante dos elementos concretos, entendeu pela não incorporação da medicação pleiteada:

Recomendação inicial da Conitec

A Conitec recomendou inicialmente a não incorporação, ao SUS, do dupilumabe, abrocitinibe e upadacitinibe para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adolescentes e do dupilumabe para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em crianças. Esse tema foi discutido durante a 129ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2024. Na ocasião, o Comitê de Medicamentos considerou que os medicamentos analisados são eficazes e seguros em relação ao placebo (subestância sem efeito), mas que nenhum deles demonstrou ser custo-efetivo de acordo com o limiar de custo-efetividade

Também não foram apresentadas evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento.

A autora acostou laudos e receitas médicas (evento 10, LAUDO3 e evento 10, RECEIT4), e um artigo jurídico (evento 10, COMP2).

Contudo, de acordo com as novas diretrizes vinculantes, a mera prescrição médica não é suficiente para justificar a concessão judicial de medicamento não integrante das listas do SUS, sendo ônus da parte autora comprovar a imprescindibilidade, segurança e eficácia do fármaco por meio de medicina baseada em evidências de alto nível.

E conforme a tese fixada, devem ser apresentadas, pela parte, *evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise,* ao que se não se presta os documentos acostados ao evento 10.

Por fim, foi solicitada avaliação do tratamento postulado para o quadro clínico da autora ao Natjus, que além de indicar não haver urgência no caso, exarou parecer desfavorável ao fornecimento da medicação, nos seguintes termos (evento 17, NOTATEC1):

> *"Conclusão Justificada:* ***Não favorável***
>
> *Conclusão:*
>
> *CONSIDERANDO o diagnóstico de Dermatite Atópica grave, conforme relatório médico acostado nos autos.*
>
> *CONSIDERANDO que embora no laudo médico (03/10/24) refira que comorbidades portadas pela paciente contraindicariam o uso da ciclosporina, devido a efeitos colaterais possíveis,* ***não foram citadas quais são estas comorbidades****.*
>
> *CONSIDERANDO que* ***há a possibilidade de uso de ciclosporina, medicação disponível no SUS para crianças e adultos e previsto no PCDT de dermatite atópica PORTARIA CONJUNTA SAES/SECTICS Nº 34, de 20 de DEZEMBRO de 2023****.* ***Segundo este documento, orienta-se prescrever a menor dose capaz de controlar a doença com o objetivo de minimizar a ocorrência de eventos adversos, com utilização recomendada por período de até 02 anos contínuos, preferencialmente não ultrapassando 8 a 12 meses de uso. Importante ressaltar que devido ao histórico de AVC hemorrágico da paciente, o monitoramento da pressão arterial frequente é imprescindível.***
>
> *CONSIDERANDO que as principais contraindicações ao uso da ciclosporina são: Hipertensão não controlada, Doenças renais e hepáticas graves, Histórico de doenças malignas, Infecções ativas graves e Alergia à ciclosporina ou a qualquer componente da formulação.*
>
> *CONSIDERANDO a idade da paciente e a recomendação final, pela CONITEC, de incorporação do dupilumabe para crianças com dermatite atópica grave e incorporação do upadacitinibe para adolescentes (12 a 18 anos) com dermatite atópica grave*
>
> ***CONCLUI-SE que NÃO HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para sustentar a indicação de Dupilumabe, no presente caso.***
>
> *Há evidências científicas? Sim*
>
> *Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?* ***Não"***

Dessa forma, não tendo a parte autora se desincumbido de atender os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234, SV n.º 60 e 61, é caso de improcedência.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado por **VITORIA BOFF DAMIAN** em face do **MUNICÍPIO DE SANTIAGO / RS e do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios aos procuradores da parte requerida, estes fixados em R$ 500,00, na forma do disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

Fica suspensa, contudo, a exigibilidade dessa verba (art. 98, § 3º, do CPC), em face do benefício da gratuidade judiciária deferido à autora.

Publicação e intimação automáticos.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões no prazo de 15 dias.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **VALERIANO SANTOS FILHO, Juiz de Direito**, em 05/06/2025, às 23:15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082453355v8** e o código CRC **83985dc4**.

---

1. "O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes". ↩